감염후기침, 시간이 약입니다

감기 후 3~8주간 지속되는 기침 — 왜 생기고 어떻게 관리하면 좋은지 알아봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

감기 뒤 기침, 약 없이도 절반 넘게 좋아집니다

감염후기침은 보통 3~8주 안에 저절로 사라집니다

50%+

약 없이 좋아짐

시간이 지나며 저절로 나아지는 비율

3~8주

보통 이어지는 기간

3~8주 기침의 가장 흔한 원인

약 25%

감기 뒤 2주 넘게

감기 뒤 기침이 2주 이상 남는 비율

왜 시간이 필요한가요

감기로 다친 기도 점막과 신경이 회복되는 시간이 필요합니다. 잘못된 헛기침 습관만 피해도 회복이 빨라집니다.

8주가 넘으면

만성 기침으로 넘어간 것이므로 **다른 원인**을 찾는 검사가 필요합니다.

Tip · 기침이 남아 있어도 열·콧물이 사라졌다면 대부분 회복 과정입니다.

근거 · 미국흉부의사협회(ACCP) 2018 기침 지침 · 유럽호흡기학회(ERS) 2020 만성기침 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

감염후기침이란

감기·독감·코로나19가 나은 뒤에도 기침만 3주 넘게 남는 상태입니다

진단

콧물·열은 사라졌는데 기침만 3주 이상 남고, 흉부 X선이 정상이며 다른 원인이 없을 때 진단합니다.

왜 생기나요

바이러스가 기도 점막을 다치게 하고 기침 신경의 감지 센서를 예민하게 만듭니다. 작은 자극에도 기침이 쉽게 납니다.

기침 과민 상태

이렇게 기침 신경이 예민해진 상태를 '기침 과민 증후군'이라 부르며, 감염후기침이 대표적인 예입니다.

얼마나 가나요

평균 3~8주 이어지며, 3~8주 기침(아급성 기침)의 가장 흔한 원인입니다.

Tip · 찬 공기·웃음·말하기에도 기침이 나는 것은 신경이 예민해졌기 때문입니다.

근거 · 미국흉부의사협회(ACCP) 2018 기침 지침 · 아급성 기침 정의

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

감기 뒤 3주 넘는 기침의 네 가지 원인

감기 뒤 기침이 남는다면 대부분 이 네 가지에서 출발합니다

1 예민해진 기관지 감염 뒤

찬 공기·먼지·웃음에도 기침이 납니다. 보통 6~10주 안에 정상으로 돌아옵니다.

2 코 뒤로 넘어가는 콧물 상기도 기침 증후군

콧물이 목 뒤로 흘러 기침을 일으킵니다. 코막힘·목 이물감·잦은 헛기침.

3 기침형 천식 밤·새벽

쌕쌕거림 없이 기침만 나는 천식. 폐기능 검사·기관지 유발 검사로 확인합니다.

4 위식도역류병 식후·누운 뒤

위산이 식도·목을 자극합니다. 속쓰림·신물을 보고 위산억제제로 확인합니다.

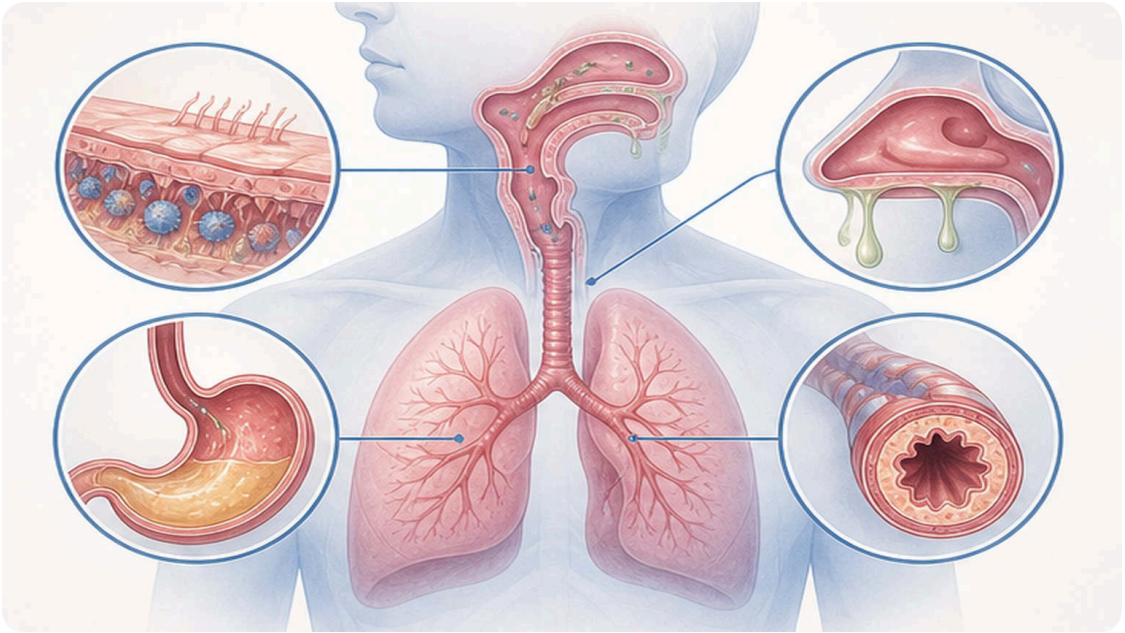


그림 · 기관지·코·위에서 각각 기침이 시작될 수 있습니다(설명용 그림).

Tip · 원인마다 치료가 달라서, 기침이 오래가면 어느 쪽인지 함께 찾아봅니다.

근거 · ACCP 2018 아급성 기침 · 대한천식알레르기학회 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

코·부비동·기관지를 함께 살핍니다

동반 코 증상과 기침의 경과를 진료 때 알려 주세요

하나로 이어진 기도

코·부비동·인두·기관지는 연속된 점막입니다. 비염 환자의 20~40%가 천식을 함께 앓아, 기침만 남아도 코와 기관지를 함께 평가합니다.

진단과 약 확인

맑은 콧물·재채기·눈 가려움, 후비루·코막힘·안면통·후각 저하를 알려 주세요. 기침형 천식·호산구성 기관지염과 ACE 억제제 등 기침 유발 약도 확인합니다.

처방을 더하기 전에 동반 증상과 실제 약 사용법을 확인합니다.

아산 28회 연수강좌 — 부비동염과 알레르기 비염 진단과 치료 전략(권혁수)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기침이 기침을 부릅니다

초기에 기침을 참으면 신경이 예민해지는 악순환을 끊을 수 있습니다

1

바이러스 감염

시작

감기·독감·코로나 바이러스가 기도 점막을 다치게 합니다.

2

신경이 예민해짐

감작

다친 점막의 염증 물질이 기침 신경을 예민하게 만듭니다.

3

작은 자극에도 기침

문턱 ↓

찬 공기·먼지·향수·웃음에도 기침이 납니다.

4

기침이 점막을 다시 다침

반복

센 기침이 반복되면 목과 기관 점막에 작은 상처가 쌓입니다.

5

기침이 오래감

8주 넘으면 만성

자극→기침→손상의 고리가 닫히며 기침이 길어집니다.

고리를 끊는 방법 기침을 의식적으로 참는 연습, 물 충분히 마시기, 자극 피하기로 신경이 예민해지는 단계에서 끊습니다.

Tip · 헛기침은 모기 물린 곳을 긁는 것과 같습니다 — 잠깐 시원하고 더 가렵습니다.

근거 · 기침 과민 증후군 · 유럽호흡기학회 전문가 보고 2014

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기침이 나오려 할 때 이렇게 해 보세요

기침 참기 연습(행동적 기침 억제 치료)은 기침 횟수를 최대 65%까지 줄였습니다

방법	이렇게
물 한 모금	천천히 삼킵니다 — 가장 쉽고 효과적
무설탕 사탕	침이 늘어 목이 촉촉 — 외출·회의 때
코로 천천히 숨	입을 다물고 4초 들이쉬고 6초 내쉽니다
입술 오므려 내쉬기	천천히 내쉬어 기침 충동을 누그러뜨립니다
힘주어 침 삼키기	삼키는 반사가 기침 반사를 누릅니다

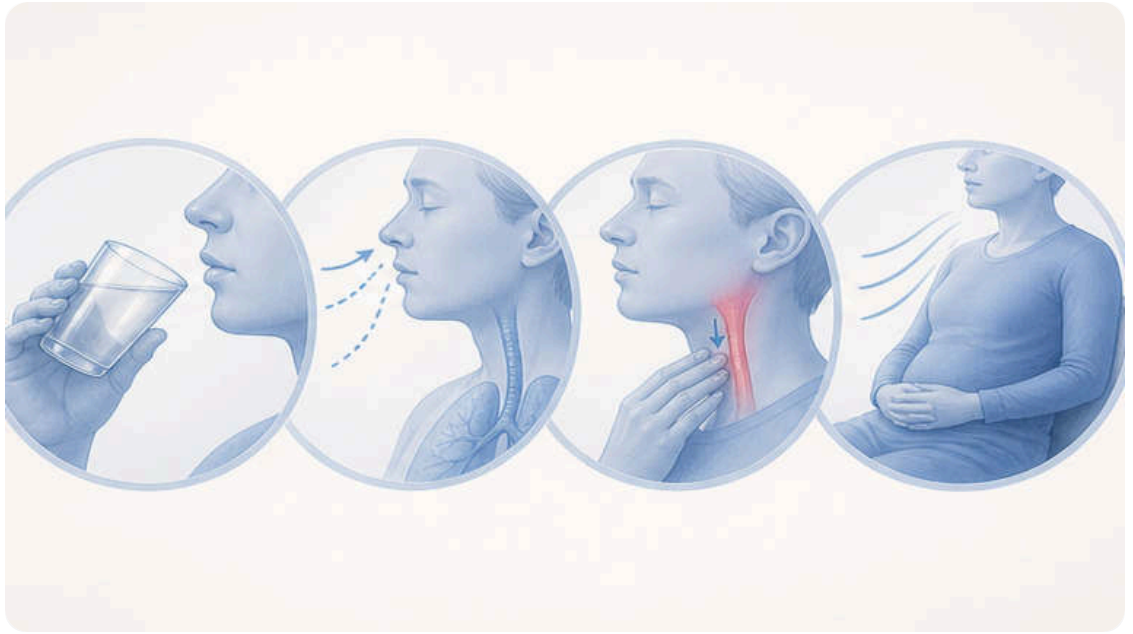


그림 · 물 삼키기 · 코 호흡 · 침 삼키기 · 입술 오므려 내쉬기(설명용 그림).

Tip · 연구에서 이 연습을 4번 받은 환자의 87%가 좋아졌다고 답했습니다.

근거 · Vertigan 등, Thorax 2006 무작위 대조 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이렇게 하시고, 이건 피하세요

헛기침 대신 부드럽게 침을 삼키는 습관이 회복을 앞당깁니다



그림 · 촉촉한 실내와 충분한 수분, 연기와 큰 소리는 피합니다(설명용 그림).

이렇게 하세요

- 물 하루 1.5~2L, 실내 습도 40~60%(가습기)
- 기침이 나오려 하면 물 삼키기·사탕
- 코로 천천히 깊게 숨쉬기
- 충분한 잠과 가벼운 규칙 운동

이건 피하세요

- 습관적인 헛기침(“에헴!”) · 흡연·간접흡연·연기
- 건조한 곳에 오래 있기 · 갑자기 찬 공기
- 큰 소리로 말하기·고함
- 카페인·술을 많이 마시기

Tip · 헛기침이 하고 싶을 때는 침을 한 번 꿀꺽 삼켜 보세요.

근거 · 아급성 기침 생활 관리 · 대한천식알레르기학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

시간이 약입니다 — 회복은 이렇게 갑니다

감염후기침은 단계적으로 약해지고, 8주가 넘으면 검사가 필요합니다

1

급성기 끝

감염 뒤 1~2주

콧물·열이 사라지고 기침만 남기 시작합니다. 기침 참기 연습을 시작하세요.

2

절반은 좋아짐

3~4주

약 없이도 50% 넘는 분이 기침 세기가 30~40% 수준으로 줄어듭니다.

3

대부분 사라짐

6~8주

예민한 기관지가 정상으로 돌아옵니다. 아토피(알레르기) 질환이 있는 분은 더 오래갈 수 있습니다.

4

만성 기침 검사

8주 넘으면

폐기능 검사·흉부 CT·후두 내시경 등 차례대로 원인을 찾습니다.

코로나19 뒤 기침 4~12주에 18~25%, 12주 뒤에도 2.5~10%에서 남고, 약 43.7%에서 기관지가 예민한 상태로 확인됩니다.

Tip · 3~4주쯤이 가장 답답한 시기입니다 — 조금만 더 기다려 보세요.

근거 · 바이러스 감염 뒤 기침의 자연 경과 · 코로나19 기침 추적 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

누런 콧물보다 호전·악화 흐름이 중요합니다

급성 감기의 잔여 기침과 3주 넘는 기침을 구분합니다

감기의 회복 흐름

감기는 대개 3~4일에 증상이 정점에 이르고 이후 호전됩니다. 코 증상은 10일 무렵 줄어도 기침·가래는 최대 3주 남을 수 있습니다. 이는 감염후기침의 3~8주 정의와 구분합니다.

다시 진료받을 경과

누런·초록 콧물만으로 항생제를 정하지 않습니다. 10일 이상 호전이 없거나, 좋아지다 5~6일째 다시 악화되거나, 39°C 이상 고열·농성콧물·안면통이 3~4일 지속되면 다시 평가합니다.

누런 색은 백혈구 성분의 영향일 수 있어 색만으로 세균 감염을 단정하지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 부비동염과 알레르기 비염 진단과 치료 전략(권혁수)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료는 생활 관리가 먼저, 약은 처방으로

증상이 심하거나 4주 넘게 이어질 때 단계적으로 약을 더합니다



그림 · 꿀·사탕·휴식 같은 생활 관리가 먼저이고, 필요하면 흡입제나 물약 같은 처방 약을 더합니다(설명용 그림).

기침 참기 연습 + 꿀

가장 먼저 권하며 부작용이 없습니다. 꿀은 기침을 줄입니다 — **12개월 미만 아기는 금지**.

물 마시기 + 자극 피하기

가래가 묽어지고 기도 자극이 줄어듭니다.

흡입 스테로이드 · 흡입 기관지확장제

기관지가 예민하면 흡입 스테로이드를 2~4주 써 봅니다. 이프라트로피움은 기도 분비를 줄입니다.

기침약 · 신경 조절 약

레보드로프로피진은 마약 성분이 없는 기침약입니다. 8주 넘게 안 나으면 가바펜틴 등을 고려합니다.

Tip · 약은 의사 처방으로만 — 기침약을 여러 개 겹쳐 먹지 마세요.

근거 · 유럽호흡기학회(ERS) 2020 만성기침 지침 · 대한천식알레르기학회 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

코분무·코세척은 사용법도 치료입니다

코 질환에 맞춰 처방받은 치료를 정확히 사용합니다

분무는 코 바깥벽 쪽으로

오른쪽 코는 왼손, 왼쪽 코는 오른손으로 잡고 노즐을 같은 쪽 귀 방향으로 향하게 합니다. 비중격에 직접 뿌리면 코피가 나기 쉽습니다.

식염수 세척은 안전한 물로

보통 하루 1~2회, 코분무 스테로이드 사용 전에 시행합니다. 끓여 식힌 물이나 멸균수를 쓰며 수돗물을 바로 쓰지 않습니다. 세척 중 침을 삼키지 않습니다.

분무 후 바로 코를 풀지 않습니다. 코피·작열감이 지속되면 방법과 제제를 상담합니다.

아산 28회 연수강좌 — 부비동염과 알레르기 비염 진단과 치료 전략(권혁수)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

위산억제제를 모든 기침에 더하지 않습니다

기침이 지속될 때 원인과 치료를 다시 확인하는 순서입니다

역류 증상이 없다면

속쓰림·신물 같은 전형적인 역류 증상이 없는 기침에서는 위산억제제(PPI·P-CAB)의 기침 개선 효과가 제한적입니다. 모든 기침에 일률적으로 더하지 않습니다.

치료 반응을 다시 확인

진단·흡입 및 분무 방법·실제 사용 여부를 확인합니다. 원인 치료 뒤에도 남는 기침에서는 신경조절제나 기침 억제 언어치료를 진료에서 검토할 수 있습니다.

위산억제제가 모든 환자에게 효과가 없거나 금기라는 뜻은 아닙니다.

아산 28회 연수강좌 — 부비동염과 알레르기 비염 진단과 치료 전략(권혁수)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상이 있으면 바로 병원으로

하나라도 해당하면 추가 검사가 필요합니다 — 한국은 결핵이 적지 않은 나라입니다

01

피 섞인 가래

폐암·결핵·기관지확장증의 신호일 수 있어 흉부 CT 등으로 바로 확인합니다.

바로 검사

02

체중 감소 + 밤 식은땀

이유 없는 체중 감소는 종양·결핵·림프종을 확인해야 합니다.

원인 확인

03

계속되는 열 · 숨참

쌕쌕거림만 있으면 당일 진료, 숨이 차면 **바로 응급실**, 말하기 힘들거나 입술이 파래지면 **119**.

숨차면 응급실 · 심하면 119

04

기침 8주 이상

만성 기침입니다. 2주가 넘었는데 흉부 사진 등 결핵 확인을 아직 안 받았다면 진료를 받으세요.

결핵 검사

Tip · 위험 신호가 없으면 대부분 시간이 지나며 좋아집니다.

근거 · 질병관리청 결핵 진료지침 · ACCP 기침 위험 신호

피가 섞인 가래는 양과 호흡 상태를 함께 봅니다

소량이라도 원인 확인과 경과 관찰이 필요합니다

검사는 서로 보완합니다

흉부 X선의 출혈 위치 확인율은 약 46%입니다. 조영 CT는 원인 약 70%·위치 약 77%를 확인하며, 필요하면 기관지내시경으로 보완합니다.

지속·반복되면 재평가

비중증 객혈도 초기 진료 후 24~48시간에 호전 여부를 재평가합니다. 지속되거나 원인이 불명확하면 추가 평가·의뢰합니다. 복용 중인 항응고제·항혈소판제를 알려 주세요.

> 빠르게 피가 늘거나 숨이 차면 기다리지 말고 응급 진료를 받습니다.
> 아산 28회 연수강좌 — 객혈 환자, 이렇게 접근하자: 진단과 치료의 핵심(이장호)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

감염후기침은 대부분 좋아지지만, 잘못된 습관이 회복을 늦춥니다

01 감염후기침은 3~8주 안에 대부분 저절로 사라집니다

02 약 없이도 절반 넘게 좋아집니다 — 시간이 약입니다

03 기침이 기침을 부르는 악순환을 의식적으로 끊으세요

04 헛기침("에헴!")은 모기 물린 곳 긁기와 같습니다

05 기침이 나오려 하면 물 삼키기·코 호흡·사탕

06 습도 40~60%, 물 하루 1.5~2L, 연기·찬 공기 피하기

07 증상이 심하면 흡입제·기침약은 처방으로만

08 피 섞인 가래·체중 감소·열·8주 넘는 기침은 병원으로

Tip · 좋아지는 속도는 사람마다 다릅니다 — 조급해하지 마세요.

근거 · 미국흉부의사협회(ACCP) 2018 기침 지침 · 대한천식알레르기학회 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 기간별 경과표·집에서 할 일·다시 올 때는 감기·기침 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

감기 뒤 기침이 오래가는 분을 위한 설명자료입니다. 약 사용과 추가 검사는 담당 의료진과 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국흉부의사협회(ACCP) 2018 기침 지침 · 유럽호흡기학회(ERS) 2020 만성기침 지침 · 대한천식알레르기학회 2024 · Vertigan, Thorax 2006

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요